ONEMA-POP-029 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-029 — Monitoramento da Hipertensão Arterial
Crônica e Reconhecimento de Descompensação

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de monitoramento da hipertensão arterial crônica e reconhecimento de descompensação em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Acompanhamento de hipertensão crônica e reconhecimento de descompensação; medidas isoladas não definem conduta medicamentosa. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: aparelho de pressão validado, manguitos adequados, estetoscópio e registro; paciente: diário de pressão e medicamentos.

5. Avaliação e preparo

Sintomas neurológicos/cardiopulmonares, técnica de medida, adesão, doses, comorbidades, quedas e hipotensão ortostática.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar identificação, repouso, postura, braço apoiado e manguito apropriado.

2. Aferir pressão e pulso com técnica padronizada, registrando braço, horário e condições; repetir se necessário.

3. Investigar cefaleia intensa, dor torácica, dispneia, déficit neurológico, alteração visual e confusão.

4. Se sinais de lesão aguda de órgão-alvo, acionar SAMU 192 independentemente do número isolado.

5. Se pressão muito elevada sem sintomas, repetir após repouso e articular avaliação médica tempestiva conforme

protocolo local.

6. Revisar adesão, horários, automedicação, AINEs e possíveis interações sem modificar prescrição.

7. Orientar automonitorização com técnica e horários pactuados e plano de comunicação de resultados.

8. Registrar medidas, sintomas, encaminhamentos e resposta.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Sintomas de AVC, síndrome coronariana, edema agudo de pulmão ou rebaixamento: emergência; não tentar reduzir rapidamente a PA em casa.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar seguimento longitudinal, atividade e dieta conforme plano multiprofissional.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 WHO 2021 — Guideline for pharmacological treatment of hypertension in adults — https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.